



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG

Terakreditasi B (Baik Sekali) BAN - PT

Program Studi :

1. Diploma III Kebidanan 2. Sarjana Keperawatan 3 Profesi Ners
4. Sarjana Gizi 5. Sarjana Kebidanan 6. Pendidikan Profesi Bidan
Alamat : Jl. Veteran Mancar Peterongan Jombang Telp./Fax. 0321 - 877025

Jombang, 24 November 2025

Nomor : 369/SHJ/S.Pen/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Permohonan Penelitian
Dan Pengambilan Data

Kepada,-
Yth. Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo Pasuruan
Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir berupa Skripsi bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Jombang Tahun Akademik 2025/ 2026, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **SITI KHUMAIROH**
NIM : 2024 03 0351
Prodi : Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang
Tempat Penelitian : Di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan
Bersama ini kami mohon agar mahasiswa termaksud mendapatkan ijin dan kesempatan melakukan studi penelitian serta diberikan data – data yang berkaitan dengan Penelitian dengan judul “ **HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI DI RUANG INSTALASI BEDAH RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN** ”.

Demikian atas bantuan dan kebijakaannya di sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Husada Jombang



Dr. Hany Puspita Aryani, dr., MM., M.Kes.

NPP. 010801059

PROPOSAL

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI DI RUANG INSTALASI BEDAH RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN



Oleh :

SITI KHUMAIROH
NIM : 2024030351

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN JOMBANG
2025**

PROPOSAL

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI DI RUANG INSTALASI BEDAH RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO PASURUAN

Proposal ini di Tujukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Keperawatan (S.Kep) Pada Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang



Oleh :

SITI KHUMAIROH
NIM : 2024030351

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN JOMBANG
2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya bersumpah bahwa Proposal ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dikumpulkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar dari berbagai jenjang pendidikan tinggi manapun

Jombang, _____ 2025

Yang menyatakan

SITI KHUMAIROH

NIM : 2024030351

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISEMINARKAN

Tanggal _____ 2025

Oleh :

Pembimbing I

Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns., M.Kep.
NPP. 010906068

Pembimbing II

Roni Setiawan, S.Kep.,Ns., M.Kep
NPP : 010906067

HALAMAN PENETAPAN PENGUJI

Proposal ini telah dipresentasikan dan di pertanggung jawabkan

Di depan tim penguji

Tanggal : _____ 2025

MENGESAHKAN,

TIM PENGUJI :

Tanda tangan

Ketua : Dr. Najah Soraya Niah, S.Sos., M.M. (.....)
NPP. 010406018

Anggota : Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns., M.Kep. (.....)
NPP. 010906068

Anggota : Roni Setiawan, S.Kep.,Ns., M.Kep (.....)
NPP. 010906067

Mengetahui,

Ketua STIKES HUSADA
JOMBANG

Ketua Prodi S1 Keperawatan

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes.,M.M
NPP. 010 704 0401

Sylvie Puspita, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NPP. 011305103

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul “Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan”.

Proposal penelitian ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi S-1 Keperawatan STIKES Husada Jombang. Dalam penyusunan Proposal penelitian ini, penulis mendapatkan banyak pengarahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang :

1. Ns. Heni Indra Wulansari. S. Kep, M. Kep selaku direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan yang telah memberikan izin penelitian sehingga peneliti dapat melakukan penelitian
2. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM., selaku Ketua STIKES Husada Jombang.
3. Sylvie Puspita, S.Kep.,Ns., M.Kep. selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang.
4. Dr. Najah Soraya Niah, S.Sos., M.M., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal.
5. Fahrur Rozi, S.Kep.,Ns., M.Kep., selaku pembimbing I yang telah mensupport dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Proposal ini.
6. Roni Setiawan, S.Kep.,Ns., M.Kep., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritikan dalam menyempurnakan Proposal ini.
7. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan moril dan material selama menempuh pendidikan
8. Suami dan anak-anakku tercinta yang tak henti memberi dukungan moril maupun materiil.
9. Seluruh Dosen dan Staf pendidikan STIKES Husada Jombang yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyelesaian pembuatan Proposal ini.

10. Sahabat seperjuangan dan sealmamater yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebbaikannya di terima disisi Allah SWT dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Proposal ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya penelitian ini selanjutnya. Mudah – mudahan Proposal ini bisa bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jombang, _____2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Penetapan Penguji.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.	7
2.1 Konsep Pre Operasi.....	7
2.2 Konsep tentang Kecemasan.	12
2.3 Dukungan Keluarga.....	26
2.4 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi.....	35
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL.....	37
3.1 Kerangka Konseptual.....	37
3.2 Hipotesis Penelitian.....	38
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	39
4.1 Desain Penelitian.....	39
4.2 Kerangkan Penelitian (Kerja).....	39
4.3 Sampling Desain.....	40
4.4 Indentifikasi Variabel.....	41

4.5	Operasional Definisi.....	42
4.6	Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
4.7	Pengumpulan Data dan Analisa Data.....	45
4.7	Etika Penelitian.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptul.....	37
Gambar 4.1 Kerangka Kerja.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Definisi Operasial.....	23
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 3 kuesioner penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Operasi merupakan tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh, yang dapat menimbulkan kecemasan pada pasien. Tujuan dari operasi adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengangkat atau memperbaiki bagian tubuh, memperbaiki fungsi tubuh dan meningkatkan kesehatan, contohnya kolesistektomi, nefrektomi, kolostomi, histerektomi, mastektomi, amputasi dan operasi akibat trauma (Brunner & Sudarth 2019). Pre operasi dimulai ketika keputusan untuk intervensi bedah dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operatif (Asmadi, 2022). Perawatan pre operasi yang efektif dapat mengurangi resiko post operasi, salah satu prioritas keperawatan pada periode ini adalah mengurangi kecemasan pasien (Smeltzer & Bare, 2019). Kecemasan yang terjadi dihubungkan dengan rasa nyeri, kemungkinan cacat dan mungkin kematian (Fridman, Potter & Perry, 2019).

Menurut Stuart (2019) kecemasan merupakan perasaan khawatir yang tidak jelas yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya, dan keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Alasan yang dapat menyebabkan ketakutan atau kecemasan pasien dalam menghadapi pembedahan antara lain adalah takut nyeri setelah pembedahan, takut terjadi perubahan fisik dan takut operasi akan gagal (Potter & Perry, 2019). Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien yang akan menjalani tindakan operasi karena penulis menemukan di lapangan masih banyak pasien

yang mengalami kecemasan dengan respon teriak, marah, menangis, menarik diri dan lain sebagainya.

Sam, Arebert dan Kenny (2020 dalam Widyanti 2022) menunjukkan beberapa penelitian di USA mengenai kecemasan yang terjadi pada kasus pembedahan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferlina (2021) ditemukan sekitar 80% dari jumlah sampel 20 orang mengalami kecemasan sebelum dilakukannya tindakan pembedahan dan 60% diantaranya mengalami kecemasan sedang dan berat. Sedikit berbeda dengan hasil yang diperoleh dengan Amaliyah (2022) RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta menemukan sekitar 65,71% pasien mengalami cemas ringan. Penelitian Makmuri (2007 dalam Puryanto, 2019) tentang tingkat kecemasan pasien pre operasi fraktur femur di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menunjukkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 40,0% yang memiliki tingkat kecemasan dalam kategori sedang, 37,5% dalam kategori ringan, responden dengan tingkat kecemasan berat 17,5% dan responden yang tidak merasa cemas sebanyak 5%. Hal ini menunjukan sebagian besar pasien pre operasi mengalami kecemasan.

Penulis merasa hal ini penting untuk diteliti karena dari data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, masih banyak pasien pre operasi yang merasa cemas saat akan menghadapi operasi dikarenakan kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, keluarga yang jauh dari pasien, baru pertama kali melakukan operasi. Untuk itu dukungan sangat dibutuhkan oleh pasien yang akan menghadapi operasi. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan telah menangani 130 kasus dari bulan Juni sampai Agustus 2024 dengan rata-rata

tiap bulan sekitar 43 kasus. (Data hasil rekam medik Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan, 2023).

Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan (sehat–sakit) klien (Yosep, 2017), Dukungan keluarga dapat memberikan rasa senang, rasa aman, rasa nyaman dan mendapatkan dukungan emosional yang akan mempengaruhi kesehatan jiwa. Apabila dukungan keluarga rendah maka dapat dipastikan pasien akan mengalami kecemasan. Kecemasan terjadi ketika seseorang merasa terancam baik fisik maupun psikologisnya misalnya harga diri, gambaran diri, dan identitas diri (Stuart & Sundeen 2019). Kecemasan tersebut dimanifestasikan secara langsung melalui perubahan fisiologis seperti (gemetar, berkeringat, detak jantung meningkat, nyeri abdomen, sesak nafas) dan perubahan perilaku seperti (gelisah, bicara cepat, reaksi terkejut) dan secara tidak langsung melalui timbulnya gejala sebagai upaya untuk melawan kecemasan (Stuat & Laraia, 2019). Hal ini dapat mengakibatkan pasien ketakutan akan operasi, tidak kooperatif dalam proses operasi dan menghambat jalannya prosedur operasi.

Oleh karena itu dukungan keluarga sangat diperlukan dalam perawatan pasien pre operasi, dapat meningkatkan semangat hidup dan menurunkan kecemasan pasien serta menguatkan komitmen pasien untuk menjalani pengobatan (Setiadi, 2022). Selain itu untuk mengatasi kecemasan pasien bukan hanya di ruang pre operasi tetapi juga di ruang rawat inap dengan memberikan edukasi tentang prosedur penatalaksanaan operasi bagi pasien dan keluarga pasien. Kecemasan ini dapat dihindari apabila ada penjelasan yang baik antara perawat dan klien yang terjalin dengan hubungan yang baik,

sehingga mampu mengurangi beban pikiran serta diharapkan dapat menghilangkan kecemasan (Mulyani, 2022). Berdasarkan uraian diatas, maka perhatian terhadap hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi perlu ditingkatkan. Apabila dukungan keluarga rendah ada atau kurang maka akan menyebabkan dampak psikologis terhadap pasien tersebut. maka diperlukan penelitian untuk melihat adakah hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut: “ Apakah ada Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Mengidentifikasi dukungan keluarga pada pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan

- 1.3.2.2 Mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien pre operasi operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan
- 1.3.2.3 Menganalisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran bagi tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi perawat

Mengoptimalkan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang mengalami kecemasan dengan memperhatikan aspek psikologis pasien pre operasi

2) Bagi Rumah Sakit

Dapat memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dan keluarga tentang pentingnya dukungan keluarga bagi pasien pre operasi

3) Bagi Responden

Memberikan masukan pada responden tentang manfaat dukungan keluarga yang dapat mengurangi kecemasan pre operasi.

4) Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan masukan bahwa dukungan keluarga sangat diperlukan dalam proses penyembuhan pasien pre operasi

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. konsep Pre Operasi

2.1.1 Pre operasi

Operasi (elektif atau kedaruratan) adalah merupakan peristiwa kompleks yang menegangkan (Brunner & Suddarth, 2019).

Pre operasi adalah fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi atau pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi (Smeltzer and Bare, 2019)

2.1.2 Tipe Pembedahan

2.1.2.1 Menurut fungsinya (tujuannya), Potter & Perry (2019) membagi menjadi:

- 1) Diagnostik : biopsi, laparotomi eksplorasi.
- 2) Kuratif (ablatif) : tumor, appendiktomi.
- 3) Reparatif : memperbaiki luka multiple.
- 4) Rekonstruktif : mamoplasti, perbaikan wajah.
- 5) Paliatif : menghilangkan nyeri.
- 6) Transplantasi : penanaman organ tubuh untuk menggantikan organ atau struktur tubuh yang malfungsi (cangkok ginjal, kornea).

Smeltzer and Bare (2019), membagi operasi menurut tingkat urgensi dan luas atau tingkat resiko

2.1.2.2 Menurut tingkat urgensinya :

1) Kedaruratan

Klien membutuhkan perhatian dengan segera, gangguan yang diakibatkannya diperkirakan dapat mengancam jiwa (kematian atau kecacatan fisik), tidak dapat ditunda.

2) Urgen

Klien membutuhkan perhatian segera, dilaksanakan 24 – 30 jam.

3) Diperlukan

Klien harus menjalani pembedahan, direncanakan dalam beberapa minggu atau bulan.

4) Elektif

Klien harus dioperasi ketika diperlukan, tidak terlalu membahayakan jika tidak dilakukan.

5) Pilihan

Keputusan operasi atau tidaknya tergantung kepada klien (pilihan pribadi klien).

2.1.2.3 Menurut Luas atau Tingkat Resiko :

1. Mayor

Operasi yang melibatkan organ tubuh secara luas dan mempunyai tingkat resiko yang tinggi terhadap kelangsungan hidup klien.

2. Minor

Operasi pada sebagian kecil dari tubuh yang mempunyai resiko komplikasi lebih kecil dibandingkan dengan operasi mayor.

2.1.3 Faktor resiko terhadap pembedahan menurut Potter & Perry (2019) antara lain :

2.1.3.1 Usia

Pasien dengan usia yang terlalu muda (bayi/anak-anak) dan usia lanjut mempunyai resiko lebih besar. Hal ini diakibatkan cadangan fisiologis pada usia tua sudah sangat menurun, sedangkan pada bayi dan anak-anak disebabkan oleh karena belum matur-nya semua fungsi organ.

2.1.3.2 Nutrisi

Kondisi malnutrisi dan obesitas/kegemukan lebih beresiko terhadap pembedahan dibandingkan dengan orang normal dengan gizi baik terutama pada fase penyembuhan. Pada orang malnutrisi maka orang tersebut mengalami defisiensi nutrisi yang sangat diperlukan untuk proses penyembuhan luka. Nutrisi-nutrisi tersebut antara lain adalah protein, kalori, air, vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin A, Vitamin K, zat besi dan seng (diperlukan untuk sintesis protein).

Pada pasien yang mengalami obesitas. Selama pembedahan jaringan lemak, terutama sekali sangat rentan terhadap infeksi. Selain itu, obesitas meningkatkan permasalahan teknik dan mekanik. Oleh karenanya defisiensi dan infeksi luka, umum terjadi. Pasien obesitas sering sulit dirawat karena tambahan berat badan; pasien bernafas tidak optimal saat berbaring miring dan karenanya mudah mengalami hipoventilasi dan komplikasi pulmonari pasca operatif.

Selain itu, distensi abdomen, flebitis dan kardiovaskuler, endokrin, hepatic dan penyakit biliari terjadi lebih sering pada pasien obesitas.

2.1.3.3 Penyakit Kronis

Pada pasien yang menderita penyakit kardiovaskuler, diabetes, PPOM (Penyakit Paru Obstruksi Menahun), dan insufisiensi ginjal menjadi lebih sukar terkait dengan pemakaian energi kalori untuk penyembuhan primer. Dan juga pada penyakit ini banyak masalah sistemik yang mengganggu sehingga komplikasi pembedahan maupun pasca pembedahan sangat tinggi.

Ketidaksempurnaan respon neuroendokrin pada pasien yang mengalami gangguan fungsi endokrin, seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol, bahaya utama yang mengancam hidup pasien saat dilakukan pembedahan adalah terjadinya hipoglikemia yang mungkin terjadi selama pembiusan akibat agen anestesi, atau juga akibat masukan karbohidrat yang tidak adekuat pasca operasi atau pemberian insulin yang berlebihan. Bahaya lain yang mengancam adalah asidosis atau glukosuria. Pasien yang mendapat terapi kortikosteroid beresiko mengalami insufisiensi adrenal. Penggunaan obat-obatan kortikosteroid harus sepengetahuan dokter anestesi dan dokter bedah.

2.1.3.4 Merokok

Pasien dengan riwayat merokok biasanya akan mengalami gangguan vaskuler, terutama terjadi arterosklerosis pembuluh darah, yang akan meningkatkan tekanan darah sistemik.

2.1.3.5 Alkohol dan obat-obatan

Individu dengan riwayat alkoholik kronik seringkali menderita malnutrisi dan masalah-masalah sistemik, seperti gangguan ginjal dan hepar yang akan meningkatkan resiko pembedahan.

2.1.4 Gambaran pasien preoperatif

Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stress fisiologis maupun psikologis. Menurut Long B.C (2020), pasien pre operasi akan mengalami reaksi emosional berupa kecemasan. Berbagai alasan yang dapat menyebabkan ketakutan/kecemasan pasien dalam menghadapi pembedahan antara lain :

1. Takut nyeri setelah pembedahan
2. Takut terjadi perubahan fisik, menjadi buruk rupa dan tidak berfungsi normal (body image)
3. Takut keganasan (bila diagnosa yang ditegakkan belum pasti)
4. Takut / cemas mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang mempunyai penyakit yang sama.
5. Takut/nyeri menghadapi ruang operasi, peralatan pembedahan dan petugas. takut mati saat dibius/tidak sadar lagi.
6. Takut operasi gagal.

Ketakutan dan kecemasan yang mungkin dialami pasien dapat mempengaruhi respon fisiologis tubuh yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik seperti : meningkatnya frekuensi nadi dan pernafasan, gerakan-gerakan tangan yang tidak terkontrol, telapak

tangan yang lembab, gelisah, menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, sulit tidur dan sering berkemih.

Persiapan yang baik selama periode operasi membantu menurunkan resiko operasi dan meningkatkan pemulihan pasca bedah. Tujuan tindakan keperawatan preoperasi menurut Luckman dan Sorensen (1993) dalam (Hidayat & Siwi, 2019), dimaksudkan untuk kebaikan bagi pasien dan keluarganya yang meliputi :

- a) Menunjukkan rasa takut dan cemasnya hilang atau berkurang (baik ungkapan secara verbal maupun ekspresi muka.
- b) Dapat menjelaskan dan mendemonstrasikan mobilisasi yang dilakukan setelah tindakan operasi.
- c) Terpelihara keseimbangan cairan, elektrolit dan nutrisi.
- d) Tidak terjadi vomitus karena aspirasi selama pasien dalam pengaruh anestesi.
- e) Tidak ada atau berkurangnya kemungkinan terjadi infeksi setelah tindakan operasi.
- f) Mendapatkan istirahat yang cukup.
- g) Menjelaskan tentang prosedur operasi, jadwal operasi serta menandatangani inform consent.

2.2. Konsep tentang Kecemasan

2.2.1 Pengertian kecemasan

Kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya dan mengancam. Kecemasan adalah respons emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami

dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab dengan tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya (Stuart dan Sunden, 2019)

Kecemasan adalah ketegangan, rasa tidak aman dan kekawatiran yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tetapi sumbernya sebagian besar tidak diketahui dan berasal dari dalam (Asmadi, 2022).

Pada tingkat panik ini, lahan persepsi sudah terganggu sehingga individu tidak dapat mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberi penghargaan/ tuntutan.

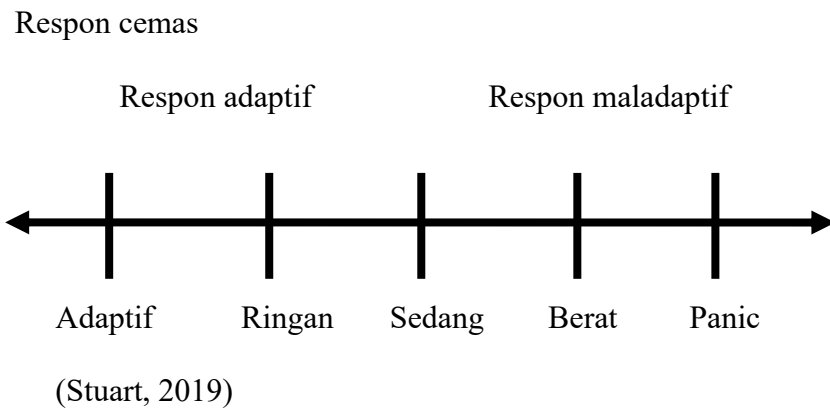
1) Respon Psikologis

- a) Napas pendek.
- b) Rasa tercekik dan palpasi.
- c) Sakit dada, pucat.
- d) Hipotensi.
- e) Koordinasi motorik rendah.

2) Respon kognitif

- a) Lapangan persepsi sangat sempit.
- b) Tidak dapat berfikir logis

2.2.2 Rentang respon kecemasan



2.2.3 Tahapan Kecemasan

Kecemasan diidentifikasi menjadi 4 tingkat yaitu, ringan, sedang, berat dan panik (Stuart & Laraia 2019). Semakin tinggi tingkat kecemasan individu maka akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikis. Kecemasan berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap bahaya.

Kecemasan merupakan masalah psikiatri yang paling sering terjadi, tahapan tingkat kecemasan akan dijelaskan sebagai berikut (Stuart 2019):

2.2.3.1 Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari, cemas menyebabkan individu menjadi waspada, menajamkan indera dan meningkatkan lapang persepsinya.

2.2.3.2 Kecemasan sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada suatu hal dan mempersempit lapang persepsi individu. Individu menjadi tidak perhatian yang selektif namun dapat berfokus pada lebih banyak area.

2.2.3.3 Kecemasan berat, mengurangi lapang persepsi individu. Individu berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan, individu perlu banyak arahan untuk berfokus pada area lain.

2.2.3.4 Tingkat panik (sangat berat) dari kecemasan berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Hal yang rinci terpecah dari proporsi, karena mengalami kehilangan kendali. Individu yang mencapai tingkat ini tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional.

2.2.4 Etiologi Kecemasan

Kecemasan disebabkan faktor patofisiologis maupun faktor situasional (Sutrimo 2017). Penyebab kecemasan tidak spesifik bahkan tidak diketahui oleh individu. Perasaan cemas diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku, dapat juga diekspresikan secara tidak langsung melalui timbulnya gejala dan mekanisme koping sebagai upaya melawan kecemasan (Stuart 2019).

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan menurut Stuart (2019) antara lain:

2.2.4.1 Faktor predisposisi

1) Teori psikoanalisis

Pandangan teori psikoanalisis memaparkan bahwa cemas merupakan konflik emosional yang terjadi antara dua elemenke pribadian yaitu id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan tersebut dan fungsi kecemasan untuk mengingatkan ego bahwa ada bahaya.

2) Teori interpersonal

Teori interpersonal menyatakan bahwa cemas timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Cemas juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah rentan mengalami kecemasan yang berat.

3) Teori perilaku

Teori perilaku menyatakan bahwa cemas merupakan produk frustrasi. Frustrasi merupakan segala sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dikarakteristikan sebagai suatu dorongan yang dipelajari untuk menghindari kepedihan. Teori pembelajaran meyakini individu yang terbiasa sejak kecil dihadapkan pada

ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan kecemasan pada kehidupan selanjutnya. Teori konflik memandang cemas sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Kecemasan terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara konflik dan kecemasan : konflik menimbulkan kecemasan, dan cemas yang menimbulkan perasaan tak berdaya, yang pada gilirannya meningkatkan konflik yang dirasakan.

4) Teori kajian keluarga

Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan cemas terjadi didalam keluarga. Gangguan kecemasan juga tumpang tindih antara gangguan kecemasan dan depresi.

Setiap perubahan dalam kehidupan yang dapat menimbulkan keadaan stres disebut stresor. Stres yang dialami seseorang dapat menimbulkan kecemasan (Ibrahim 2017). Faktor predisposisi yang dapat menimbulkan kecemasan antara lain faktor genetik, faktor organik dan faktor psikologi. Faktor predisposisi kecemasan pada pasien pre operasi yang paling berpengaruh merupakan faktor psikologis, terutama ketidakpastian tentang prosedur dan operasi yang akan dijalani (Gant & Cunningham 2019).

2.2.4.2 Faktor presipitasi

Pengalaman cemas setiap individu bervariasi bergantung pada situasi dan hubungan interpersonal. Ada dua faktor presipitasi yang mempengaruhi kecemasan menurut Stuart (2019) dan yaitu :

1). Faktor eksternal

(1) Ancaman integritas diri

Meliputi ketidakmampuan fisiologis atau gangguan terhadap kebutuhan dasar (penyakit, trauma fisik, pembedahan yang akan dilakukan).

(2) Ancaman konsep diri

Antara lain: ancaman terhadap identitas diri, harga diri, hubungan interpersonal, kehilangan, dan perubahan status dan peran.

2). Faktor internal

(1). Potensial stressor

Stresor psikososial merupakan keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehingga individu dituntut untuk beradaptasi.

(2). Maturitas

Kematangan kepribadian individu akan mempengaruhi kecemasan yang dihadapinya. Kepribadian individu yang lebih matur maka lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena individu mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap kecemasan.

(3). Pendidikan

Tingkat pendidikan individu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka individu semakin mudah berpikir rasional dan menangkap

informasi baru. Kemampuan analisis akan mempermudah individu dalam menguraikan masalah baru.

(4). Respon koping

Mekanisme koping digunakan seseorang saat mengalami kecemasan. Ketidakmampuan mengatasi kecemasan secara konstruktif merupakan penyebab terjadinya perilaku patologis.

(5). Status sosial ekonomi

Status sosial ekonomi yang rendah pada seseorang akan menyebabkan individu mudah mengalami kecemasan.

(6). Keadaan fisik

Individu yang mengalami gangguan fisik akan mudah mengalami kelelahan fisik. Kelelahan fisik yang dialami akan mempermudah individu mengalami kecemasan.

(7). Tipe kepribadian

Individu dengan tipe kepribadian A lebih mudah mengalami gangguan akibat kecemasan dari pada orang dengan tipe kepribadian B. Individu dengan tipe kepribadian A memiliki ciri-ciri individu yang tidak sabar, kompetitif, ambisius, ingin serba sempurna, merasa diburu-buru waktu, mudah gelisah, tidak dapat tenang, mudah tersinggung dan mengakibatkan otot-otot mudah tegang. Individu dengan tipe kepribadian B memiliki ciri-ciri yang berlawanan dengan tipe kepribadian A. Tipe kepribadian B merupakan individu yang penyabar, tenang, teliti dan rutinitas.

(8). Lingkungan dan situasi

Seseorang yang berada di lingkungan asing lebih mudah mengalami kecemasan dibandingkan lingkungan yang sudah dikenalnya.

(9). Dukungan sosial

Dukungan sosial dan lingkungan merupakan sumber coping individu. Dukungan sosial dari kehadiran orang lain membantu seseorang mengurangi kecemasan sedangkan lingkungan mempengaruhi area berfikir individu.

(10). Usia

Usia seseorang yang mempunyai usia lebih muda ternyata lebih muda mengalami gangguan akibat kecemasan daripada seseorang yang lebih tua usianya.

(11). Jenis kelamin

Gangguan kecemasan tingkat panik lebih sering dialami wanita dari pada pria. Dampak negatif dari kecemasan merupakan rasa khawatir yang berlebihan tentang masalah yang nyata maupun potensial. Keadaan cemas akan membuat individu menghabiskan tenaganya, menimbulkan rasa gelisah, dan menghambat individu melakukan fungsinya dengan adekuat dalam situasi interpersonal maupun hubungan sosial (Videbeck, 2022).

Faktor presipitasi timbulnya kecemasan pada pasien pre operasi pada faktor eksternal pada ancaman integritas dirinya karena

prosedur operasi, kekhawatiran yang mengenai pada sistem diri pasien berupa kekhawatiran terhadap gambaran diri yang nantinya berpengaruh pada hubungan interpersonalnya (Sutrimo 2017).

Faktor presipitasi internal kecemasan pasien pre operasi antara lain potensial stressor yaitu prosedur tindakan menggunakan metode operasi yang akan dijalannya, maturitas individu yakni pasien operasi yang berusia produktif, pendidikan pasien, respon koping pasien, status sosial ekonomi keluarga dalam memenuhi administrasi rumah sakit mulai dari persiapan sebelum sampai setelah operasi, keadaan fisik pasien, tipe kepribadian pasien, lingkungan di rumah sakit serta dukungan sosial pasien dari keluarga maupun tenaga kesehatan di rumah sakit (Gant & Cunningham 2019).

Menurut Robby (2019) Pengalaman masa lalu terhadap penyakit yang positif maupun negatif dapat mempengaruhi perkembangan ketrampilan menggunakan koping. Keberhasilan seseorang pada masa lalu dapat membantu individu untuk mengembangkan ketrampilan menggunakan koping, sebaliknya kegagalan atau reaksi emosional menyebabkan seseorang menggunakan koping yang maladaptif terhadap stressor tertentu.

2.2.5 Penatalaksanaan Kecemasan

Aspek klinik menyatakan bahwa kecemasan dapat dijumpai pada orang yang menderita stres normal, pada orang yang menderita sakit fisik berat lama dan kronik, dan pada orang dengan gangguan psikiatri berat.

Kecemasan yang berkepanjangan menjadi patologis dan menghasilkan berbagai gejala hiperaktivitas otonom pada sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, gastrointestinal bahkan genitourinarius. Respon kecemasan yang berkepanjangan dinamakan gangguan kecemasan (Sutrimo 2017). Penyembuhan gangguan kecemasan dapat dilakukan dengan cara farmakologis mau pun non farmakologis menurut Maramis (2019) yaitu sebagai berikut :

2.2.5.1 Farmakologis

Terapi farmakologis yang diberikan untuk menurunkan kecemasan terdiri dari obat *anxiolytic* dan psikoterapi. *Anxiolytic* mempunyai keunggulan efek terapeutik cepat dalam menurunkan tanda dan gejala kecemasan tetapi mempunyai kerugian risiko adiksi. Obat *anxiolytic* diberikan sampai 2 minggu pengobatan, kemudian dilakukan psikoterapi yang dimulai pada awal minggu kedua. Saat psikoterapi diberikan, obat *anxiolytic* masih tetap diberikan tetapi secara bertahap diturunkan dosisnya (*tapering off* sampai minggu ke empat pengobatan). Jenis obat yang digunakan sebagai agen *anxiolytic* yaitu golongan benzodiazepin, non-benzodiazepin, anti-depresan: trisiklik, *Monoamin Oxidase Inhibitor* (MAOI), *Serotonin Reuptake Inhibitor* (SRI), *Specific Serotonin Reuptake Inhibitor* (SSRI) (Sutrimo 2017). Pengobatan farmakologi *anxiolytic* mempunyai efek klinik *tranquilaizer* dan *neroleptika* (Maramis, 2019).

2.2.5.2 Non farmakologi

Terapi non farmakologis untuk menurunkan kecemasan dilakukan dengan psikoterapi. Psikoterapi yang digunakan untuk gangguan kecemasan merupakan psikoterapi berorientasi *insight*, terapi perilaku, terapi kognitif atau psikoterapi provokasi kecemasan jangka pendek (Sutrimo 2017). Nursalam (2020) mengemukakan bahwa untuk menurunkan stressor yang dapat memperberat kecemasan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Menurunkan kecemasan dengan teknik distraksi yang memblok persepsi nyeri dalam korteksserebral.
- 2) Relaksasi dapat menurunkan respon kecemasan, rasa takut, tegang dan nyeri. Teknik relaksasi terdapat dalam berbagai jenis yaitu latihan nafas dalam, visualisasi dan *guide imagery*, *biofeedback*, meditasi, teknik relaksasi autogenik, relaksasi otot progresif dan sebagainya.
- 3) Pendidikan kesehatan membantu pasien dengan gangguan kecemasan untuk mempertahankan kontrol diri dan membantu membangun sikap positif sehingga mampu menurunkan ketergantungan terhadap medikasi.
- 4) Memberikan bimbingan pada klien dan keluarga dengan gangguan kecemasan untuk membuat pilihan perawatan diri sehingga memungkinkan klien terlibat dalam aktivitas pengalihan. Bimbingan yang diberikan dapat berupa bimbingan fisik maupun mental.

- 5) Dukungan keluarga meningkatkan mekanisme koping dalam menurunkan stres dan kecemasan.

Penatalaksanaan keperawatan mandiri berdasarkan *Nursing Intervention Classification* (NIC) yang dianjurkan untuk tindakan menurunkan kecemasan yaitu penurunan kecemasan, teknik menenangkan, pengembangan mekanisme koping, pendampingan pasien, kehadiran perawat dan konseling lewat telepon. NIC untuk diagnose kecemasan juga dianjurkan dalam kategori intervensi lain yaitu konseling, pedoman antisipasi, terapi seni, terapi autogenik, manajemen sikap, distraksi, humor, hipnosis, meditasi, terapi musik, terapi otot progresif, bimbingan imajinasi, relaksasi, pendidikan kesehatan (Mc Closkey & Bulechek, 2022).

2.2.6 Tingkatan kecemasan

Stuard dan Sunden, (2019) mengemukakan beberapa teori tingkat kecemasan menjadi 4 tingkatan yaitu :

2.2.6.1 Kecemasan ringan

Kecemasan berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan sehari-hari pada tingkat ini lapangan persepsi meningkat dan individu akan berhati-hati dan waspada, terdorong untuk belajar yang akan menghalalkan pertumbuhan dan kreativitas.

2.2.6.2 Kecemasan sedang

Pada tingkat ini lapangan persepsi terhadap lingkungan menurun, individu lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal lain.

2.2.6.3 Kecemasan berat

Pada kecemasan berat lapangan persepsi menjadi sangat menurun individu cenderung memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang lain, individu tidak mampu berfikir realistis dan membutuhkan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada area lain.

2.2.7 Penilaian Kecemasan DASS (*Depression Anxiety Stress Scale*)

Nursalam (2020), Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan menggunakan DASS (*Depression Anxiety Stress Scale*) yang terdiri dari 21 item yaitu:

- 1) Saya merasa sulit untuk beristirahat.
- 2) Saya merasa bibir saya sering kering.
- 3) Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif.
- 4) Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: seringkali terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya).
- 5) Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu.
- 6) Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi.
- 7) Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan).
- 8) Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas.
- 9) Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri.
- 10) Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan.

- 11) Saya menemukan diri saya mudah gelisah.
- 12) Saya merasa sulit untuk bersantai.
- 13) Saya merasa putus asa dan sedih.
- 14) Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya
untuk menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan.
- 15) Saya merasa saya hampir panik.
- 16) Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun.
- 17) Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia.
- 18) Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung.
- 19) Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak sehabis
melakukan aktivitas fisik (misalnya: merasa detak jantung meningkat
atau melemah).
- 20) Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas.
- 21) Saya merasa bahwa hidup tidak berarti.

(1). Skala Penilaian

- 0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah.
- 1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang
kadang.
- 2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat
dipertimbangkan, atau lumayan sering.
- 3 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali.

- (2). Skor untuk masing-masing responden selama masing-masing
sub-skala. Kemudian dievaluasi sesuai dengan keparahan-
rating indeks di bawah :

1. Normal : 0 – 7
2. Kecemasan ringan : 8 – 9
3. Kecemasan Sedang : 10 – 14
4. Kecemasan Berat : 15 – 19
5. Kecemasan Sangat Berat: >20

2.3. Dukungan Keluarga

2.3.1 Pengertian Keluarga

Friedman (2010) dalam Setiadi (2022) mengemukakan bahwa keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

Sedangkan menurut Notoatmojo (2022). Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

2.3.2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga merupakan hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga atau sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh keluarga. Terdapat beberapa fungsi keluarga menurut Notoatmodjo (2022) yaitu sebagai berikut :

2.3.2.1 Fungsi Afektif

Fungsi afektif merupakan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan kepribadian dari anggota keluarga. Merupakan respon dari keluarga terhadap kondisi dan situasi yang dialami tiap anggota keluarga baik senang maupun sedih dengan melihat bagaimana cara keluarga mengekspresikan kasih sayang.

2.3.2.2 Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi tercermin dalam melakukan pembinaan sosialisasi pada anak, membentuk nilai dan norma yang diyakini anak, memberikan batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh pada anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Bagaimana keluarga produktif terhadap sosial dan bagaimana keluarga mempertahankan anak dengan dunia luar dengan belajar berdisiplin, mengenal budaya dan norma melalui hubungan interaksi dalam keluarga sehingga mampu berperan dalam masyarakat.

2.3.2.3 Fungsi Perawatan Kesehatan

Fungsi perawatan kesehatan keluarga merupakan fungsi keluarga dalam melindungi keamanan dan kesehatan seluruh anggota keluarga serta menjamin kebutuhan pengembangan fisik, mental dan spiritual dengan cara memelihara dan merawat anggota keluarga serta mengenal kondisi sakit tiap keluarga.

2.3.2.4 Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya melalui keefektifan sumber dana keluarga. Mencari sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penghasilan keluarga, menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2.3.2.5 Fungsi Biologis

fungsi biologis, bukan hanya ditujukan untuk meneruskan keturunan tapi untuk memelihara dan membesarkan anak untuk kelanjutan generasi selanjutnya.

2.3.2.6 Fungsi Psikologis

Fungsi psikologis, terlihat bagaimana keluarga memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga dan memberikan identitas keluarga.

2.3.2.7 Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan diberikan keluarga dalam rangka memberikan pengetahuan, ketrampilan, membentuk perilaku anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.

2.3.3 Tugas keluarga dalam bidang kesehatan

Friedman (2010) dikutip dari Setiadi (2022). Membagi 5 tugas keluarga dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan yaitu :

- 2.3.3.1 Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya. Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti dan karena kesehatanlah kadang seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga habis orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan berubah-berubah yang di alami anggota keluarga. Perubahan sekecilapapun yang di alami keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, maka apabila menyadari adanya perubahan perlu segera di catat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan beberapa besar perubahanya.
- 2.3.3.2 Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampnan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga tindakan kesehatan yang di lakukan oleh keluarga di harapkan tepat agar masalah kesehatan dapat di alami atau bahkan teratasi. Jika keluar mempunyai keterbatasan dan meminta bantuan kepada orang lain di lingkungan di sekitar keluarga.
- 2.3.3.3 Memberikan keperawatan anggota keluarga yang sakit atau yang tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang terlalu mudah. perawatan ini dapat dilakukan di rumah apabila keluarga memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk

memperoleh tindakan lanjutan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi.

2.3.3.4 Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga keluarga memainkan peran yang bersifat mendukung anggota keluarga yang sakit. Dengan kata lain perlu adanya sesuatu kecocokan yang baik antara kebutuhan keluarga dan asupan sumber lingkungan bagi pemeliharaan kesehatan anggota keluarga.

2.3.3.5 Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan (pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada). Hubungan yang bersifat positif akan memberi pengaruh baik pada keluarga mengenai fasilitas kesehatan. Di harapkan dengan hubungan yang positif terhadap pelayanan kesehatan akan merubah setiap perilaku anggota keluarga mengenai sehat sakit.

2.3.4 Pengertian dukungan keluarga

Notoatmodjo (2022) mengatakan dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga di pandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan.

Notoatmodjo (2022) mengatakan keluarga memiliki beberapa bentuk dukungan yaitu:

2.3.4.1 Dukungan Emosional

Yaitu keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Dukungan ini berupa dukungan simpatik dan empati, cinta, kepercayaan dan penghargaan. Dengan demikian seorang ibu menjelang persalinan operasi merasa dirinya menanggung beban sendiri tetapi masih ada orang lain yang memperhatikan, mau mendengarkan segala keluhannya terhadap persoalan yang dihadapinya.

2.3.4.2 Dukungan Penilaian (*appraisal*)

Keluarga bertindak sebagai sebuah umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan masalah dan sebagai sumber dan validator identitas keluarga. Penilaian merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan seseorang kepada pihak lain berdasarkan kondisi sebenarnya dari penderita. Penilaian ini dapat positif dan negatif yang pengaruhnya berarti bagi seseorang.

2.3.4.3 Dukungan Instrumental

Keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit. Dukungan instrumental ini bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam melakukan aktifitasnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya, atau menolong secara langsung kesulitan yang dihadapi, misalnya dengan menyediakan peralatan lengkap dan memadai bagi ibu dan bayinya, menyediakan kebutuhan lain yang mungkin akan dibutuhkan.

2.3.4.4 Dukungan Informatif

Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan diseminator (penyebar informasi). Bantuan informasi yang disediakan agar dapat digunakan oleh seseorang dalam menanggulangi persoalan-persoalan yang dihadapi, meliputi pemberian nasehat, pengarahan, ide-ide atau informasi lainnya yang dibutuhkan dan informasi ini dapat disampaikan kepada orang lain yang mungkin menghadapi persoalan yang sama atau hampir sama.

2.3.5 Manfaat dukungan keluarga

Notoatmodjo (2022), dukungan keluarga dapat mendukung emosi, instrumental, penghargaan dan informasi yang bermanfaat bagi individu dalam;

- 2.3.5.1 Meningkatkan produktivitas bila di hubungan dengan pekerjaan
- 2.3.5.2 Meningkatkan kesejahteraan psikologi dan penyesuaian diri dengan rasa memiliki, memperjelas identitas diri, menambah harga diri, serta mengurangi stres.
- 2.3.5.3 Meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik.
- 2.3.5.4 Mengelola terhadap stres dengan menyediakan pelayanan, rawatan, sumber-sumber informasi dan umpan balik yang dibutuhkan untuk menghadapi stres dan tekanan.

2.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga

Notoatmodjo (2022), faktor-faktor mempengaruhi dukungan keluarga adalah:

2.3.6.1 Faktor internal

- 1) Usia atau Tahap Perkembangan

Artinya dukungan keluarga dapat di tentukan oleh faktor usia dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian setiap rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan kesehatan berbeda-beda.

2) Pendidikan atau Tingkat Pengetahuan

Keyakinan seseorang terhadap adanya dukungan terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakan pendidikan dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktot yang berhubungan dengan penyakit-penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya.

3) Faktor Emosional

Faktor emosional juga mempengaruhi terhadap adanya dukungan dan cara melaksanakanya seseorang yang mengalami respon stress dalam perubahan hidupnya cenderung berrespon terhadap berbagai tanda sakit, mungkin dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa sakit itu dapat mengancam kehidupanya seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit. Seseorang individu yang tidak mampu melakukan koping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin ia menyangkal adanya gejala penyakit pada dirinya sendiri.

4) Spiritual

Aspek spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupan, menyangkut nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam kehidupan.

2.3.6.2 Faktor Eksternal

1) Praktik di keluarga

Bagaimana cara keluarga memberikan dukungan biasanya mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatanya, misalnya: klien juga akan melakukan tindakan pencegahan jika melakukan hal yang sama.

Setiadi (2022) Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang pekerjaan utamanya adalah menjalankan atau mengolah rumah keluarganya, merawat anggota keluarga dan mendidik anak-anaknya, memasak dan menyimpan makanan, membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, membersihkan dan memelihara rumah.

2) faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan berreaksi terhadap penyakitnya.

3) latar belakang budaya

Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan individu dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan pribadi.

Setiadi (2022) kehadiran dan pendampingan keluarga saat menjalani operasi akan membawa ketenangan dan menjauhkan pasien dari stress. Kehadiran keluarga akan membawa pengaruh secara psikologis, dan berdampak pada kesiapan pasien secara fisik. Kehadiran keluarga, sentuhan tangannya doa dan kata-kata penuh motivasi yang di ucapkannya akan membuat pasien merasa lebih kuat dan tabah meghadapai rasa sakit dan kecemasannya, serta memiliki motivasi untuk berjuang saat menjalankan operasi

2.3.7 Penilaian Dukungan Keluarga

Alat yang digunakan untuk mengukur dukungan keluarga menggunakan kuesiner (*The Personal Resource Questionnaire*) The PRQ 2000 (Notoatmodjo, 2022): yang terdiri dari 15 item yaitu

- 1) Saya mempunyai seseorang yang dekat dan membuat rasa aman.
- 2) Saya bergabung dalam kelompok dimana saya dapat merasa berarti
- 3) Orang-orang sekitar saya mengatakan saya melakukan tugas dengan baik
- 4) Saya mempunyai hubungan dengan seseorang yang membuat saya merasa special

- 5) Saya meluangkan waktu bersama dengan orang-orang yang mempunyai minat / hobi yang sama
- 6) Orang lain mengatakan senang bekerja dengan saya
- 7) Akan ada beberapa orang yang bersedia menolong saya jika dibutuhkan dalam waktu yang panjang
- 8) Bersama dengan teman-teman saya, kami saling tolong menolong
- 9) Saya berkesempatan untuk mendukung orang lain dalam membangun minat dan kemampuannya
- 10) Saya mempunyai keluarga atau teman yang akan selalu membantu saya walaupun saya tidak dapat membalasnya
- 11) Saat saya merasa kesal, akan ada seseorang dimana saya bisa menjadi diri sendiri
- 12) Saya tahu bahwa orang lain menghargai saya sebagai seorang manusia
- 13) Saya mempunyai seseorang yang menyayangi dan peduli tentang saya
- 14) Saya mempunyai keluarga atau teman yang bisa untuk saling berbagi dan bersenang-senang bersama
- 15) Saya merasa dibutuhkan oleh seseorang

(1). Skala Penilaian:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1 : Sangat tidak setuju | 2 : Tidak Setuju |
| 3 : Setuju | 4 : Sangat setuju |

(2) Penilaian dukungan keluarga, menentukan derajat dengan cara menjumlahkan nilai skor dari item 1 – 15 dengan hasil :

Skor 1 – 20 = Dukungan keluarga rendah

Skor 21 – 40 = Dukungan keluarga sedang

Skor 41 – 60 = Dukungan keluarga tinggi

2.4. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi

Menurut Suci.A.N.H (2022) Dukungan keluarga yang terbesar adalah kategori kurang 56,2% dan paling sedikit adalah kategori baik 43,8%. Untuk tingkat kecemasan kategori tertinggi adalah sedang 56,2% dan yang paling sedikit adalah kategori ringan 43,8%. Berdasarkan uji *chi square* di dapat *p*-value = 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima berarti ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang perawatan bedah Baji Kamase 1 dan 2 RSUD Labuang Baji Makasar.

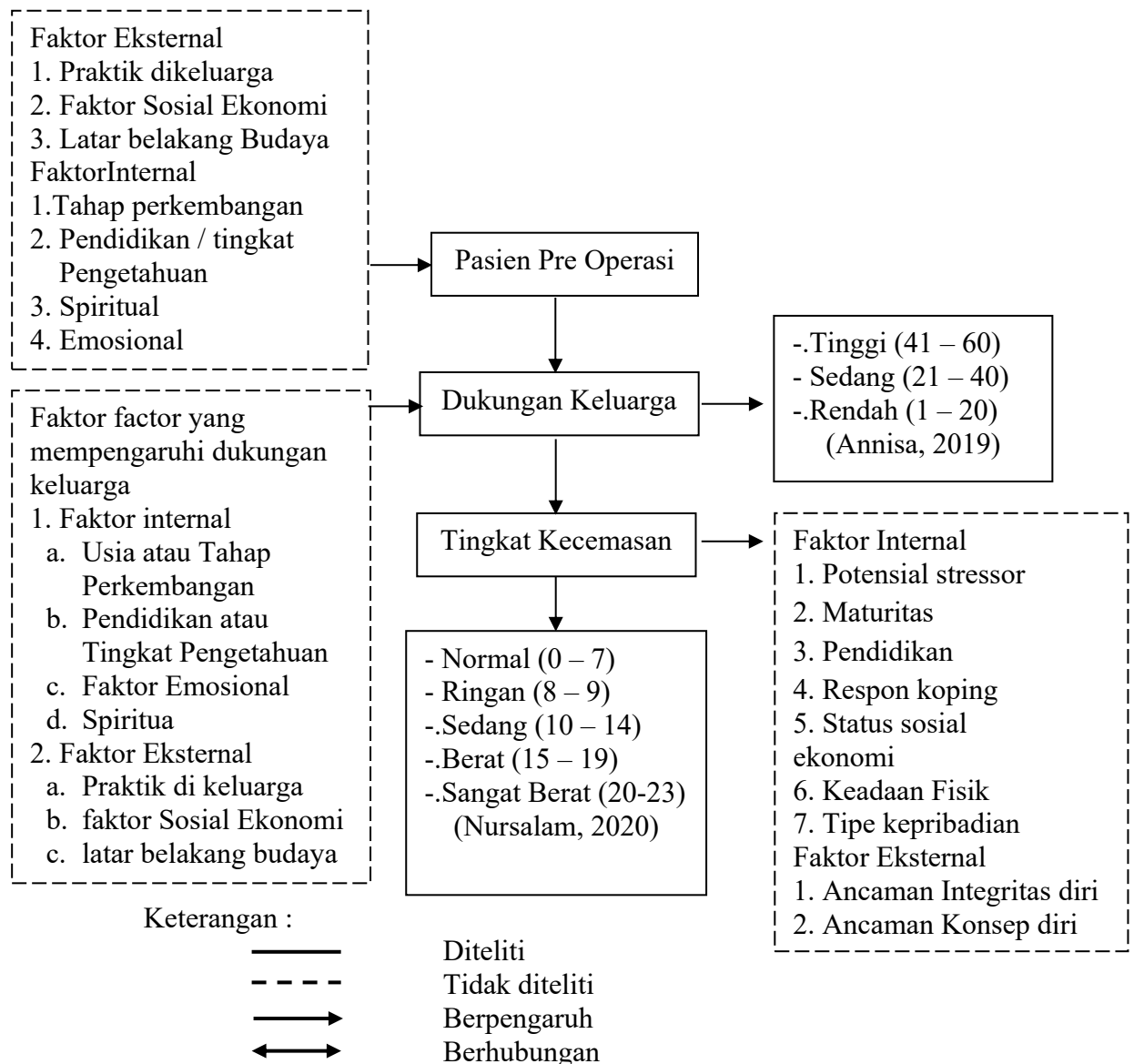
Menurut Resita.P.P (2021) Sebagian besar pasien pre operasi memiliki dukungan keluarga baik sebanyak 33 responden (67,7%) dan tingkat kecemasan pasien pre operasi adalah ringan sebanyak 27 responden (52,9%). Hasil uji statistik didapatkan nilai *p* value besar 0,000 ($p < \alpha$) yang berarti ada hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut konsep yang dipakai dengan landasan berfikir dalam kegiatan ilmu (Nursalam, 2020).



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual ada Hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

3.2. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah sebuah pertanyaan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. (Notoatmojo, 2017). Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam, 2020). Hipotesis dalam Penelitian adalah :

H^1 = Ada Hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan

BAB 4

METODE PENELITIAN

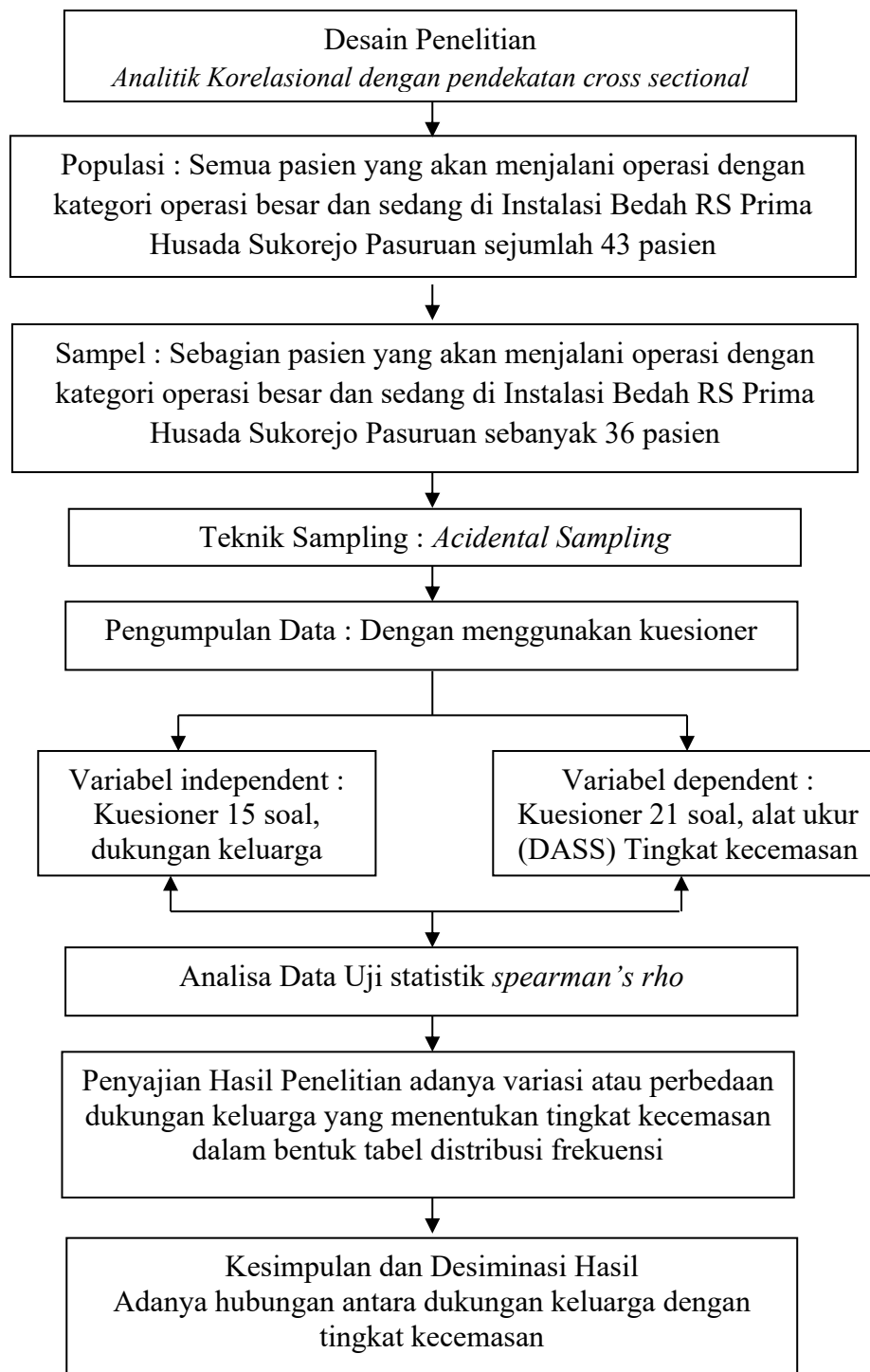
4.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini yaitu menggunakan desain penelitian *Analitik Korelasional* yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi – variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain dan dengan demikian dalam rancangan korelasional peneliti melibatkan paling tidak dua variabel (Nursalam, 2020).

Metode yang digunakan yaitu *cross sectional*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relative pendek dan tempat tertentu..

4.2. Kerangka Penelitian (Kerja)

Merupakan langkah – langkah dalam aktivitas ilmiah, mulai dari penetapan populasi, sampel dan seterusnya yaitu kegiatan sejak awal penelitian akan dilaksanakan. (Nursalam, 2020).



Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

4.3. Sampling Desain

4.3.1 Populasi Penelitian

Adalah setiap subyek (misalnya manusia, pasien) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2020). Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan sejumlah pasien.

4.3.2 Besar Sampel

Besar sampel adalah banyaknya anggota yang dijadikan sampel (Nursalam, 2020). Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 - 25% atau lebih (Arikunto, 2022).

Adapun perkiraan besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{43}{1 + 43 (0,05^2)}$$

$$n = 35,3$$

$$n = 36 \text{ responden}$$

Keterangan :

n : besarnya sampel

N : besarnya populasi

d : tingkat ketepatan absolut

4.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili suatu populasi (Nursalam, 2020). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi

1. Kriteria inklusi

- a. Bersedia menjadi responden
- b. Pasien pre op besar meliputi SC, Laparotomi, Orif, BPH, Apendix
- c. Tidak dalam keadaan gangguan jiwa

2. Kriteria eksklusi

- a. Pasien yang dalam keadaan tidak stabil

4.3.3 Teknik Sampling

Adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2020). Penelitian ini menggunakan teknik sampling tipe *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya (Sugiyono, 2019).

4.4. Identifikasi Variabel

Adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu (benda, manusia dan lain – lain) (Nursalam, 2020). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

4.4.1 Variabel independen / variabel bebas

Adalah variabel yang manipulasi, diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain (Nursalam, 2020). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah dukungan keluarga

4.4.2 Variabel dependen / variabel tergantung

Adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas atau variabel independen (Notoatmodjo, 2017). Variabel tergantung dari penelitian ini tingkat kecemasan pasien pre operasi.

4.5. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2020).

Tabel 4.1 Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Skala	Score
Variabel bebas : dukungan keluarga	Kemampuan dukungan keluarga tentang pre operasi	Dukungan keluarga: 1. Pengertian dukungan keluarga 2. Fungsi keluarga 3. Tugas keluarga 4. Manfaat dukungan keluarga 5. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga	Kuesioner PRQ 2000	Ordinal	1. Dukungan keluarga Tinggi = 41 - 60 2. Dukungan keluarga Sedang = 21 - 40 3. Dukungan keluarga Rendah = 1 - 20
Variabel tergantung : Tingkat kecemasan terhadap preoperasi	respon emosional terhadap penilaian intelektual terhadap tindakan pembedahan	1. Saya merasa sulit untuk beristirahat. 2. Saya merasa bibir saya sering kering. 3. Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif. 4. Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: seringkali terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya). 5. Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. 6. Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi. 7. Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan). 8. Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas. 9. Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri. 10. Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan.	Kuesioner DASS	Ordinal	1. Normal : 0 – 7 2. Kecemasan Ringan : 8 – 9 3. Kecemasan Sedang : 10 – 14 4. Kecemasan Berat : 15 – 19 5. Kecemasan Sangat Berat : 20 - 23

		11. Saya menemukan diri saya mudah gelisah. 12. Saya merasa sulit untuk bersantai 13. Saya merasa putus asa dan sedih. 14. Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan. 15. Saya merasa saya hampir panik. 16. Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun. 17. Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia. 18. Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung. 19. Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak sehabis melakukan aktivitas fisik (misalnya: merasa detak jantung meningkat atau melemah). 20. Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas. 21. Saya merasa bahwa hidup tidak berarti.		
--	--	--	--	--

4.6. Waktu dan Tempat Penelitian

4.6.1 Waktu

Penelitian ini dimulai dengan penyusunan Proposal dan pengambilan data awal pada bulan oktober sampai Oktober 2023, kemudian penelitian dilaksanakan pada bulan November 2025.

4.6.2 Tempat

Di Ruang Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan

4.7. Pengumpulan Data dan Analisa Data

4.7.1 Pengumpulan Data

4.6.1.1 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner jenis *close ended question* dengan jumlah 36 pertanyaan yang dibagi pada masing – masing variabel, yaitu dukungan keluarga 15 soal dan variabel tingkat kecemasan 21 soal.

4.6.1.2 Prosedur Pengumpulan Data

- 1) Mengurus perizinan penelitian kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.
- 2) Melakukan pendekatan kepada pasien dan keluarga pasien dan memberikan penjelasan bila bersedia menjadi responden dipersilahkan menandatangani *informed concent*

- 3) Responden dipersilahkan mengisi semua daftar pertanyaan dalam angket yang diberikan dalam waktu 15 menit kemudian diserahkan kepada peneliti.

4.6.1.3 Analisa Data

1). Analisa Deskriptif

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data melalui tahapan pengecekan kelengkapan data pada setiap variabel. Untuk nilai dukungan keluarga menjumlahkan nilai skor dari item 1 sampai 15, sedangkan skor untuk tingkat kecemasan sama dengan menjumlahkan nilai skor dari item 1 sampai 21.

Penelitian masing – masing terdiri dari 2 kategori yaitu :

Untuk variabel dukungan keluarga dengan menggunakan alat ukur The PRQ 2000 (*The Personal Resource Questionnaire*) sebagai berikut :

a) Skala penilaian:

- 1 : Sangat tidak setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Kadang tidak setuju
- 4 : Netral
- 5 : Kadang setuju
- 6 : Setuju
- 7 : Sangat setuju

b) Penilaian dukungan keluarga, Menentukan derajat dengan cara menjumlahkan nilai skor dan item 1- 15 dengan hasil :

1. Kategori dukungan keluarga tinggi : 41 – 60
2. Kategori dukungan keluarga sedang : 21 – 40
3. Kategori dukungan keluarga kurang : 1 – 20

Untuk variabel kecemasan diukur dengan menggunakan alat ukur DASS (*Depression Anxiety Stress Scale*) sebagai berikut :

1. Skala penilaian :

- 0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah.
- 1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang kadang.
- 2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau lumayan sering.
- 3 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali.

2. Penilaian kecemasan, Menentukan derajat dengan cara menjumlahkan nilai skor dan item 1- 21 dengan hasil :

1. Normal : 0 – 7
2. Stress ringan : 8 – 9
3. Stress Sedang : 10 – 14
4. Stress Berat : 15 – 19
5. Stress Sangat Berat : > 20

2). Analisa Statistik

Data yang telah terkumpul dilakukan analisa deskriptif koreklasi dengan menggunakan uji spearman rho kemudian dimasukkan kedalam tabel distribusi yang dikonfirmasi dalam bentuk prosentase. Untuk mempelajari hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi dengan menggunakan kepercayaan / ketepatan $P = 0,05$.

Dari hasil uji statistik *chi square* dapat diambil rumusan sebagai berikut :

- a. Jika X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel maka H_1 diterima dimana terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi, sedang H_0 ditolak.
- b. Jika X^2 hitung lebih kecil dari X^2 tabel maka H_0 diterima dimana tidak ada hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi, sedang H_1 ditolak.

4.8. Etika Penelitian

4.8.1 *Informed Concent* (lembar persetujuan)

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk berpartisipasi atau menolak menjadi reponden. Pada *informed concent* juga perlu dicantumkan bahwa data diperoleh hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu

4.8.2 *Anonimity* (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subyek, peneliti tidak akan mencantumkan nama subyek pada lembar pengumpulan data, cukup diberi kode tertentu.

4.8.3 *Confidentiallity* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subyek dijamin oleh peneliti hanya kelompok data tertentu saja yang akan disajikan atau laporkan sebagai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. 2019. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta. EGC.
- Alimul, Aziz H. 2017. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta : Salemba Medika.
- Annisa. F. 2019. *Predicting Factors of Burden among Family Caregivers of Patients with Schizophrenia in Surabaya, Indonesia*. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 10: 87-97
- Arikunto, 2022. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta : Jakarta
- Asmadi. 2022. *Kebutuhan dasar manusia*, Jakarta : Salemba Medika.
- Barbara, C. Long. 2019. *Perawatan Medikal Bedah (Suatu Pendekatan Proses Keperawatan)*. Jakarta: EGC
- Brunner and Suddarth. 2019. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*, edisi 8 volume 2. Jakarta : EGC
- Cunningham, FG., et al. 2017. *Obstetri Williams (Williams Obstetri)*. Jakarta : EGC
- Dongoes, Marilyn E. 2017. *Recana Asuhan keperawatan*. Ed. 3. Jakarta : EGC
- Friedman. M.M. 2019. *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. Alih Bahasa, Ina DRL., Yoakm A, Yasmin A., Setiawan, Monica E., Edisi 3. Jakarta: EGC.
- Hawari, Dadang. 2022. *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*. Jakarta: FKUI
- Hidayat, A. I., & Siwi, A. S. (2019). *Manajemen Kecemasan pada Pasien Pre Operasi: Literature Review*. Journal of Bionursing, 1(1), 111-121
- Komang Ayu Henny. 2019. *Aplikasi Praktik Asuhan Keperawatan Keluarga* Cetakan 1. Jakarta : Sagung Seto
- Luckman dan Soransen. 1993. *Medical Surgical Nursing (ed. Ke-4)*. Philadelphia : W.B Saunders Company.
- Maramis. 2022. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya : Airlangga.
- Mc Closkey and Bulechek. 2022. *Nursing Intervention Classification (NIC)*. 5th edition. St. Louis. Mosby Elsever.
- Notoatmodjo, S. 2019. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Notoatmodjo Soekidjo (2017). *Metodologi Penelitian Kesehatan Jilid 3*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Nursalam. 2020. *Konsep Keperawatan dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Potter and Perry, A. G. 2022. *Buku ajaran Fundamental Keperawatan: Kosep, Proses, Dan Praktek*, edisi 4, Volume 2. Jakarta: EGC.
- Resita P.P. 2019. *Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi Sectio Caesarea di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto*. <https://repository.shb.ac.id>
- Setiadi. 2022. *Konsep Proses Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Smeltzer SC., Bare BG. 2019. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta : EGC.
- Smeltzer, Suzanne C. Dan Bare, Brenda G, 2019, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* Brunner dan Suddarth (Ed.8, Vol. 1,2), Alih Bahasa oleh Agung Waluyo...(dkk), EGC, Jakarta.
- Stuart dan Laraia. 2019. *Buku Saku Keperawatan Jiwa (Terjemahan)*. Jakarta : EGC.
- Stuart W. G dan J. Sunden. 2017. *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi 5. Cetakan Pertama. Buku Penerbit Kedokteran Jiwa. Jakarta : EGC.
- Suci A.N.H. 2022. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi di ruang Perawatan Bedah Baji Kamase 1 dan 2 Rumah Sakit Labuang Baji makasar*. repository.uin-alaudidin.ac.id
- Sutrimo, A. 2017. *Pengaruh GIM terhadap kecemasan pasien pre operasi SC di RSUD Banyumas*. akademik.unsoed.ac.id
- Veber.A.S. 2020. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi di ruan Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong*. elib.stikesmuhgombong.ac.id
- Videbeck, Sheila L. 2022. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta : EGC.
- Widyanti. 2022. *Pengaruh Teknik Relaksasi Otot Progresif Terhadap terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Laparatomi di ruang Inap Bedah RSUP Dr. Djamil Padang*. repo.unand.ac.id
- Robby, BEE. 2019. *Konsep Dasar Keperawatan Gawat Darurat*. KMB. Jakarta:EGC
- Musbikin, I. 2022. *Panduan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka

Lampiran 1

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan STIKES HUSADA JOMBANG :

Nama : Siti Humairoh

NIM : 2024030351

Saat ini sedang mengadakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir di Program Studi S1 Keperawatan STIKES HUSADA JOMBANG. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

Saya mengharapkan partisipasi Anda yang menjadi subjek dalam penelitian ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Identitas dan jawaban Anda akan dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan. Anda dapat memilih untuk menghentikan atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini kapan pun tanpa ada tekanan. Jika Anda bersedia menjadi peserta penelitian ini, tolong perhatikan petunjuk pengisian kuesioner dalam pernyataan-pernyataan yang ada dan menandatangani formulir persetujuan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang Anda berikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jombang, November 2025

Peneliti

Responden

(Siti Humairoh)

()

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia berpartisipasi sebagai responden penelitian yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang yang berjudul Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Ruang Instalasi Bedah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

Responden

(.....)

Data Demografi

1. Nama (Inisial) :
2. Usia : ☐ 17 - 29 tahun ☐ 30 - 42
tahun
☐ 43 - 55 tahun ☐ 56 – 68
tahun
3. JenisKelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
4. Pendidikan : ☐ SD ☐ SLTP
☐ SLTA ☐ PT
5. Status Perkawinan : ☐ Single ☐ Cerai
☐ Menikah
6. Pekerjaan : ☐ Swasta ☐ Tidak bekerja ☐
Wiraswasta
☐ IRT ☐ Pensiun
☐ PNS/TNI/POLRI
7. RiwayatOperasi : ☐ Baru pertama operasi
☐ Sudah pernah operasi
8. Keluarga mendampingi: ☐ Ada yang mendampingi
☐ Tidak ada yang mendampingi

Dengan ini saya bersedia untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

The PRQ 2000 (*The Personal Resource Questionnaire*)

Kuesioner Sumber Dukungan Keluarga

Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan yang sebagaimana orang mungkin setuju atau tidak setuju. Silahkan Anda memberi tanda silang (X) pada kolom isi sesuai dengan yang anda rasakan saat ini. Skala penilaian berupa :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (1) Sangat tidak setuju | (4) setuju |
| (2) Tidak Setuju | (5) Sangat setuju |

No	PERNYATAAN	1	2	3	4
1.	Saya mempunyai seseorang yang dekat dan membuat rasa aman				
2.	Saya bergabung dalam kelompok dimana saya dapat merasa berarti				
3.	Orang-orang sekitar saya mengatakan saya melakukan tugas dengan baik				
4.	Saya mempunyai hubungan dengan seseorang yang membuat saya merasa special				
5.	Saya meluangkan waktu bersama dengan orang-orang yang mempunyai minat/hobi yang sama				
6.	Orang lain mengatakan senang bekerja dengan saya				
7.	Akan ada beberapa orang yang bersedia menolong saya jika dibutuhkan dalam waktu yang panjang				
8.	Bersama dengan teman-teman saya, kami saling tolong menolong				
9.	Saya berkesempatan untuk mendukung orang lain dalam membangun minat dan kemampuannya				
10.	Saya mempunyai keluarga atau teman yang akan selalu membantu saya walaupun saya tidak dapat membalasnya				
11.	Saat saya merasa kesal, akan ada seseorang dimana saya bisa menjadi diri sendiri				
12.	Saya tahu bahwa orang lain menghargai saya sebagai seorang manusia				

13. Saya mempunyai seseorang yang menyayangi dan peduli tentang saya
14. Saya mempunyai keluarga atau teman yang bisa untuk saling berbagi dan bersenang-senang bersama
15. Saya merasa dibutuhkan oleh seseorang

Harap diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima kasih.

KUESIONER DASS

Petunjuk Pengisian

Kuesioner ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah.
- 1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang kadang.
- 2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau lumayan sering.
- 3 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali.

Selanjutnya, Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk menjawab dengan cara **memberi tanda silang (X)** pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara.

No	PERNYATAAN	0	1	2	3
1	Saya merasa sulit untuk beristirahat				
2	Saya merasa bibir saya sering kering.				
3	Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif.				
4	Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: seringkali terengah-engah atau tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya).				
5	Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu.				
6	Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi.				
7	Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan).				
8	Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas.				
9	Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri.				
10	Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan.				
11	Saya menemukan diri saya mudah gelisah.				
12	Saya merasa sulit untuk bersantai.				
13	Saya merasa putus asa dan sedih.				
14	Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan.				
15	Saya merasa saya hampir panik.				
16	Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun.				
17	Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia.				
18	Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung.				

19	Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak sehabis melakukan aktivitas fisik (misalnya: merasa detak jantung meningkat atau melemah).				
20	Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas.				
21	Saya merasa bahwa hidup tidak berarti.				